

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

1. Introducción y relevancia clínica

La **enfermedad inflamatoria intestinal (EII)** comprende un grupo de patologías crónicas del tracto digestivo caracterizadas por **inflamación intestinal recurrente**, mediada por mecanismos inmunológicos inapropiados frente a la microbiota intestinal.

Las dos formas principales son:

- **Colitis ulcerosa (CU):** inflamación crónica y continua limitada a la mucosa del colon y recto.
- **Enfermedad de Crohn (EC):** inflamación transmural, discontinua, que puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo (desde la boca hasta el ano).

Ambas entidades comparten síntomas como diarrea crónica, dolor abdominal, pérdida de peso y manifestaciones extraintestinales.

Su curso es **recurrente y remitente**, alternando períodos de brotes inflamatorios y remisiones.

En Chile, la incidencia de EII ha aumentado en las últimas décadas, asociada a cambios ambientales y dietarios.

La **Colitis Ulcerosa** sigue siendo más frecuente que la **Enfermedad de Crohn**, pero ambas tienen impacto relevante en la calidad de vida y riesgo de cáncer colorrectal.

En el **EUNACOM**, este tema es habitual por su frecuencia creciente, por la necesidad de diferenciar Crohn de CU y por los enfoques terapéuticos escalonados.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La EII es una enfermedad multifactorial que surge de la interacción entre **factores genéticos, inmunológicos, ambientales y microbianos**.

2.1. Factores predisponentes

- **Genéticos:** mutaciones en el gen *NOD2* y otros relacionados con la respuesta inmune innata.
- **Ambientales:** dieta occidental rica en grasas, tabaquismo (favorece Crohn y protege parcialmente de CU), uso de AINEs y antibióticos.

- **Microbiota intestinal alterada:** disbiosis con pérdida de bacterias beneficiosas.
- **Respuesta inmune anómala:** activación exagerada de linfocitos T y liberación de citoquinas proinflamatorias (TNF- α , IL-12, IL-23).

2.2. Colitis ulcerosa

Afecta principalmente la **mucosa y submucosa** del colon, iniciándose siempre en el **recto** y extendiéndose de forma continua hacia proximal.

Produce **úlceras superficiales** y **pseudopólipos**; en fases avanzadas, la mucosa se adelgaza y puede desarrollar displasia.

2.3. Enfermedad de Crohn

Compromete la pared intestinal de forma **transmural**, con lesiones segmentarias (“en parches”) separadas por zonas sanas (“en empedrado”).

Puede afectar cualquier segmento digestivo, aunque el **íleon terminal y colon derecho** son los más comprometidos.

Causa **fístulas, estenosis y abscesos** debido a la profundidad de la inflamación.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones intestinales comunes

- **Diarrea crónica**, con o sin sangre.
- **Dolor abdominal tipo cólico**, más frecuente en Crohn.
- **Pérdida de peso y anorexia**.
- **Fiebre en brotes activos**.
- **Tenesmo y urgencia defecatoria**, característicos de CU.

3.2. Manifestaciones extraintestinales

- **Articulares:** artritis periférica, espondilitis anquilosante.
- **Cutáneas:** eritema nudoso, pioderma gangrenoso.

- **Oculares:** uveítis, epiescleritis.
- **Hepatobiliares:** colangitis esclerosante primaria (asociada a CU).

3.3. Diferencias clínicas clave

Colitis ulcerosa:

- Compromiso continuo del colon, iniciando en recto.
- Diarrea con sangre y moco.
- Sin compromiso transmural ni fístulas.
- Mayor riesgo de cáncer colorrectal.

Enfermedad de Crohn:

- Compromiso segmentario, transmural.
 - Dolor abdominal y pérdida de peso marcados.
 - Fístulas perianales o enteroentéricas frecuentes.
 - Afecta íleon y colon derecho, puede haber malabsorción y déficit nutricional.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **PCR y VSG elevadas:** indican inflamación activa.
- **Anemia:** por sangrado crónico o ferropenia.
- **Hipoalbuminemia:** marcador de inflamación crónica.
- **Calprotectina fecal:** marcador no invasivo de inflamación intestinal activa (útil para diferenciar de síndrome de intestino irritable).

4.2. Estudios endoscópicos

El **estudio de elección** es la **colonoscopia con biopsia**, que permite observar la extensión, severidad y patrón inflamatorio.

Hallazgos:

- CU: mucosa friable, erosiones, úlceras superficiales, compromiso continuo.
- Crohn: úlceras aftoides, lesiones en parches, aspecto en empedrado, compromiso del íleon.

Las **biopsias múltiples** son esenciales para confirmar diagnóstico y descartar infección o displasia.

4.3. Imágenes

- **Enterorresonancia o enterotomografía:** evalúan extensión y complicaciones del Crohn (estenosis, abscesos, fístulas).
- **Ecografía abdominal:** útil para seguimiento no invasivo.

4.4. Diagnóstico diferencial

- Infecciones intestinales (amebiasis, Shigella, Campylobacter).
- Colitis isquémica.
- Síndrome de intestino irritable.
- Colitis por radiación o fármacos.

5. Tratamiento (según MINSAL 2023, ECCO y ACG)

El tratamiento busca **inducir y mantener la remisión**, evitando brotes y complicaciones.

El enfoque es escalonado, dependiendo de la extensión, gravedad y respuesta al tratamiento previo.

5.1. Tratamiento de colitis ulcerosa

A. Formas leves a moderadas:

- **Aminosalicilatos (5-ASA):** mesalazina oral o tópica (supositorios o enemas).

- Mecanismo: antiinflamatorio local.
- Dosis: 2–4 g/día oral, 1 g rectal.
- Primera línea para inducción y mantenimiento de remisión.

B. Formas moderadas a severas:

- **Corticoides sistémicos:** prednisona 40–60 mg/día, luego descenso progresivo.
- Si refractaria: considerar **corticoides IV (hidrocortisona o metilprednisolona)**.
- En pacientes dependientes o refractarios:
 - **Azatioprina o 6-mercaptopurina** (inmunomoduladores).
 - **Biológicos anti-TNF:** infliximab, adalimumab.

C. Refratariedad o complicaciones graves:

- Indicación quirúrgica: **colectomía total**, curativa en CU.
-

5.2. Tratamiento de enfermedad de Crohn

A. Formas leves a moderadas:

- **Budesonida oral** (9 mg/día) o mesalazina en casos localizados.
- **Antibióticos (ciprofloxacino o metronidazol)** si hay compromiso perianal.

B. Formas moderadas a severas:

- **Corticoides sistémicos** (prednisona 1 mg/kg/día).
- **Inmunomoduladores:** azatioprina, 6-mercaptopurina, metotrexato.
- **Biológicos:** infliximab, adalimumab, vedolizumab o ustekinumab.

C. Cirugía:

- Indicada por **estenosis, fístulas o abscesos** refractarios.

- No es curativa (alta recurrencia postoperatoria).
-

5.3. Tratamiento de mantenimiento

- **Mesalazina** en CU leve-moderada.
 - **Azatioprina o biológicos** en enfermedad refractaria o corticodependiente.
 - Evitar corticoides prolongados (riesgo de dependencia).
-

5.4. Tratamiento de complicaciones

- **Fístulas y abscesos:** drenaje quirúrgico o antibióticos.
 - **Deficiencias nutricionales:** suplemento de hierro, calcio, vitamina D, B12.
 - **Riesgo de cáncer colorrectal:** colonoscopia cada 1–2 años tras 8 años de evolución.
-

6. Complicaciones

Colitis ulcerosa:

- **Megacolon tóxico:** dilatación >6 cm del colon con fiebre, dolor y riesgo de perforación.
- **Hemorragia masiva.**
- **Displasia y cáncer colorrectal.**

Enfermedad de Crohn:

- **Estenosis intestinal** con obstrucción.
- **Fístulas y abscesos abdominales o perianales.**

- **Malabsorción, déficit vitamínico y desnutrición.**
 - **Cáncer de intestino delgado o colon.**
-

7. Pronóstico

- La EI tiene curso **crónico y recurrente**, con brotes alternados con remisiones.
 - Con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes mantiene buena calidad de vida.
 - Los biológicos han reducido la necesidad de cirugía y hospitalización.
 - En CU, la colectomía es curativa; en Crohn, la enfermedad puede reaparecer tras la cirugía.
-

8. Prevención y seguimiento

1. **Evitar AINEs y tabaco** (empeoran la enfermedad).
 2. **Vacunación completa** antes de iniciar inmunosupresores (hepatitis B, influenza, neumococo).
 3. **Tamizaje endoscópico periódico** para displasia o cáncer.
 4. **Apoyo nutricional y psicológico.**
 5. **Adherencia terapéutica:** evitar suspensión de 5-ASA o inmunomoduladores.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **colitis ulcerosa** compromete solo el colon y siempre incluye el recto.
2. La **enfermedad de Crohn** puede afectar todo el tubo digestivo y es transmural.

3. En **CU**, el tratamiento de primera línea es **mesalazina oral o tópica**.
4. En **Crohn**, el uso de corticoides o biológicos es más frecuente.
5. En presencia de **megacolon tóxico**, el manejo inicial es con corticoides IV y vigilancia intensiva.
6. La **colonoscopia con biopsia** es el examen diagnóstico clave.
7. En EUNACOM, es frecuente distinguir Crohn vs CU en base a extensión, profundidad y patrón inflamatorio.

Errores comunes:

- Usar antibióticos empíricos sin descartar EII.
- Mantener corticoides prolongadamente sin inmunomodulador.
- No vacunar antes de biológicos.
- No controlar colonoscópicamente pacientes con larga evolución.
- Confundir EII con síndrome de intestino irritable por síntomas similares.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **EII** agrupa la **colitis ulcerosa** y la **enfermedad de Crohn**, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino.
2. La **CU** afecta solo el colon (mucosa continua), mientras que el **Crohn** es transmural y segmentario.
3. El **diagnóstico** se realiza con **colonoscopia y biopsia**, apoyado por calprotectina fecal.
4. El tratamiento busca **inducir y mantener la remisión** con 5-ASA, corticoides, inmunomoduladores y biológicos.
5. Las **complicaciones** incluyen megacolon tóxico, fístulas y cáncer colorrectal.
6. La **vigilancia endoscópica** es esencial tras 8 años de enfermedad.
7. El manejo integral incluye control nutricional, vacunación y apoyo multidisciplinario.